திட்ட உணவுக் கொள்கைகள்

அதிக கலோரி, அதிக புரதம், அதிக கார்போஹைட்ரேட், மிதமான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கொழுப்பு, அதிக வைட்டமின் கொண்ட உணவுகள் கல்லீரல் செல்களை மீண்டும் உற்பத்தி செய்யவும், நீர்த்தேக்கத்தை தடுக்கவும் உதவுகிறது. கூடுதலாக வைட்டமின் மருந்துகள் கொடுக்கலாம். நீர்த்தேக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் சோடியத்தின் அளவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

திட்ட உணவு மேலாண்மை

சக்தி: ஒரு நாளைக்கு 2000-2500 கி.கலோரிகள் தேவைப்படும். தூக்கமின்மை மற்றும் குமட்டலின் காரணமாக பல நோயாளிகளுக்கு தேவையான கலோரிகள் கிடைப்பதில்லை மூன்று வேளை அதிக உணவுவை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து இடைவெளிவிட்டு அடிக்கடி குறைந்த அளவு உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

கார்போஹைட்ரேட்: ஒரு நாளைக்கு உணவில் கார்போஹைட்ரேடின் அளவை 300-400 கிராம் வரை அதிகரிக்கலாம். இதனால் கலோரியின் அளவு அதிகரிப்பதுடன் புரதம் சக்தியாக மாறும் வேலை குறைகிறது.

புரதம்:அதிக புரத உணவு கல்லீரல் செல்களின் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது.

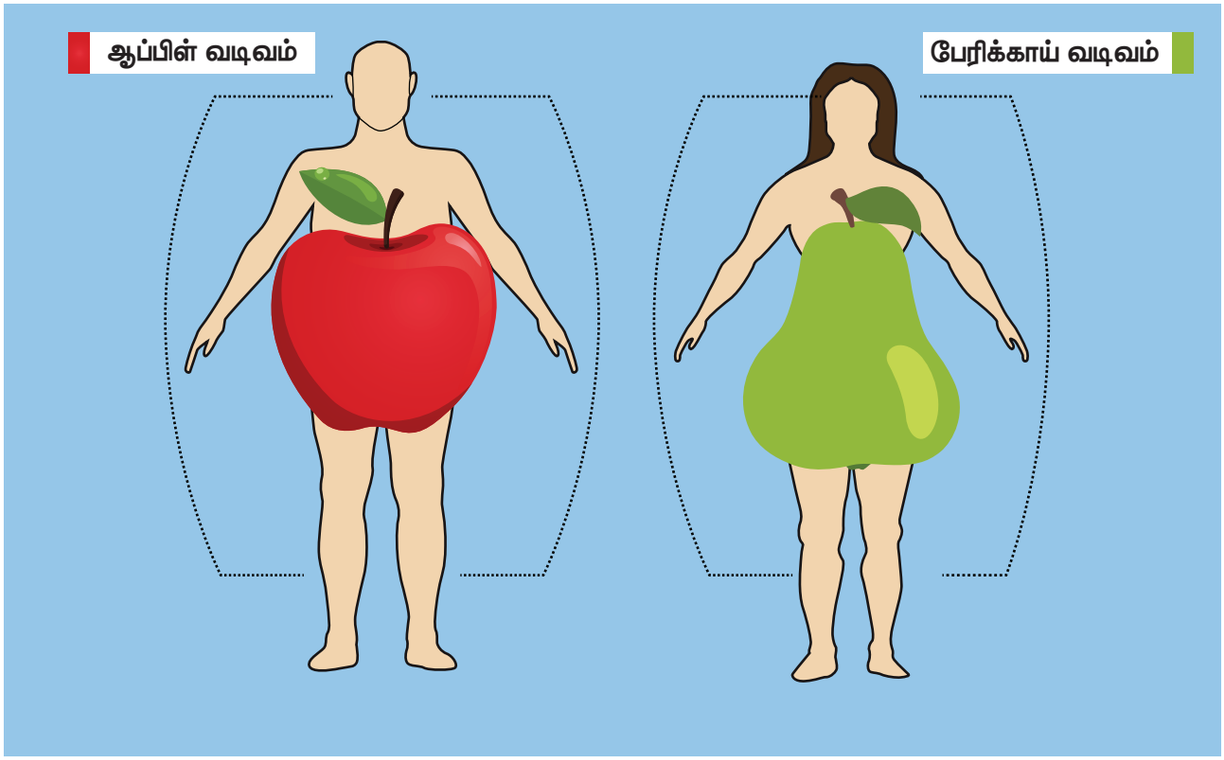
கொழுப்பு: சிர்ரோஸிஸினால் அவரியுறும் நோயாளிக்கு 20 கி கொழுப்பு கொடுக்கலாம். நடுத்தர சங்கிலி தொடர் உள்ள கொழுப்பான டிரைகிளிசரைடு கொடுக்க வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தேங்காய் எண்ணெய்யில் மிதமான சங்கிலி தொடர் டிரைகிளிசரைடு அதிகம் உள்ளது.

வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகள்: அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகள் கூடுதலாக தேவைப்படும்.

சோடியம்: நீர்த்தேக்கம் அல்லது நீர்கோர்வை இருக்கும் பட்சத்தில் சோடியத்தின் அளவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.



XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 17 20-04-2020 3.43.47 PM